BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Hồ sơ quản lý điều dưỡng và minh chứng tiêu chí C6.1

Hệ thống quản lý điều dưỡng được thiết lập đầy đủ và hoạt động hiệu quả

Bản hoàn thiện để trình thẩm định và sử dụng trong tự đánh giá nội bộ

Ngày rà soát tài liệu: 13/10/2026. Kỳ đánh giá: ……

Tài liệu cụ thể hóa bản C6.1 anh cung cấp thành hướng dẫn đối chiếu, dự thảo quy định và biểu mẫu thu thập minh chứng. Chưa có dữ liệu thực tế để kết luận mức đạt của bệnh viện. Quyết định, nhân sự, tỷ lệ, kết quả nghiên cứu và sáng kiến phải được xác nhận bằng hồ sơ có thật.

Nội dung	Thông tin xác nhận
Mã hồ sơ và phiên bản	HS-C6.1 — phiên bản trình thẩm định 1.0
Người biên soạn	……
Người thẩm định	……
Người phê duyệt	……
Số quyết định và ngày hiệu lực	……

Giữ nguyên file nguồn C6.1.docx. Các mã tài liệu trong bộ này là đề xuất để bệnh viện đưa vào hệ thống quản lý văn bản; chưa phải mã đã ban hành.

Nội dung hồ sơ

1 Căn cứ và nguyên tắc sử dụng

2 Đối chiếu tiêu chí C6.1 và minh chứng

3 Tổ chức quản lý điều dưỡng

4 Quy định chăm sóc người bệnh

5 Quy trình tổ chức chăm sóc toàn diện

6 Quy trình bàn giao người bệnh

7 Phân cấp chăm sóc và theo dõi nguy cơ

8 Chỉ số chất lượng và kế hoạch giám sát

9 Đào tạo nghiên cứu và cải tiến

10 Biểu mẫu sử dụng

11 Rà soát trước ban hành và nguồn đối chiếu

1 Căn cứ và nguyên tắc sử dụng

Căn cứ chính: Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0, tiêu chí C6.1 tại trang in 91–92; Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện. Thông tư 31 thay thế Thông tư 07/2011/TT-BYT. Khi triển khai kỳ đánh giá, Phòng Quản lý chất lượng đối chiếu thêm hướng dẫn kiểm tra của Bộ Y tế và cơ quan quản lý áp dụng cho chính kỳ đó.

Bộ tiêu chí năm 2016 có dẫn chiếu văn bản cũ. Việc chấm từng tiểu mục cần bám văn bản tiêu chí và hướng dẫn kỳ đánh giá; việc tổ chức chăm sóc hiện tại cần tuân thủ văn bản chuyên môn đang có hiệu lực. Không tự sửa điều kiện chấm mức thành các tiêu chuẩn do bệnh viện đề xuất.

QĐ 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 áp dụng khi biên soạn các quy trình kỹ thuật liên quan trong danh mục điều dưỡng. Bộ hồ sơ này chủ yếu gồm quản lý, tổ chức chăm sóc, bàn giao và biểu mẫu nên không ép toàn bộ tài liệu vào đề cương một kỹ thuật. Các quy trình kỹ thuật riêng phải có 7 phần và các mục chuẩn bị 5.1–5.9 theo QĐ 3023, kèm căn cứ chuyên môn của kỹ thuật.

C6.1 tập trung hệ thống quản lý điều dưỡng. Tư vấn giáo dục sức khỏe thuộc trọng tâm C6.2; theo dõi, chăm sóc và phân cấp chăm sóc thuộc trọng tâm C6.3. Các phần chăm sóc trong bộ này là tài liệu hỗ trợ liên thông, không thay thế bảng đối chiếu C6.1.

Xếp mức theo phương pháp của Bộ tiêu chí: kiểm tra điều kiện mức 1 trước, sau đó xét đầy đủ các yêu cầu ở mức đề nghị và các mức thấp hơn. Không lấy điểm trung bình của các tiểu mục, không dùng một công thức cộng KPI để tuyên bố đạt mức 5. Hồ sơ mẫu chưa điền hoặc kế hoạch chưa thực hiện chưa chứng minh được kết quả hoạt động.

Các tần suất giám sát hàng tháng, mục tiêu 95%, lịch triển khai và lựa chọn phần mềm dưới đây là đề xuất nội bộ để thẩm định. Hồ sơ chăm sóc điện tử, mã vạch và bảng theo dõi dữ liệu là phương tiện hỗ trợ; không tự coi chúng là điều kiện độc lập bảo đảm mức 5 C6.1.

2 Đối chiếu tiêu chí C6.1 và minh chứng

Bảng dưới đây diễn giải ngắn gọn từng tiểu mục theo bản 2.0 để quản lý minh chứng; không thay thế nguyên văn Bộ tiêu chí. Ghi kết quả là Đạt, Chưa đạt hoặc Chưa đủ minh chứng; ghi rõ mã hồ sơ, kỳ và người xác minh. Mọi dòng đang để trống kết quả.

2.1 Điều kiện mức 1 cần kiểm tra

Mục	Điều kiện cần kiểm tra	Hồ sơ đối chiếu
1	Chưa thành lập Hội đồng điều dưỡng.	Quyết định thành lập hoặc kiện toàn.
2	Chưa thành lập phòng hoặc tổ điều dưỡng theo đối tượng áp dụng.	Quyết định tổ chức, hạng và tình trạng phân hạng.
3	Chưa bổ nhiệm đầy đủ điều dưỡng trưởng; xem ngoại lệ vị trí vừa nghỉ trong vòng 6 tháng.	Danh sách vị trí, quyết định, ngày nghỉ và phương án bổ sung.

Kết quả kiểm tra điều kiện mức 1:
……

2.2 Các tiểu mục mức 2

Mục	Yêu cầu diễn giải	Minh chứng và kết quả
4	Hội đồng đã thành lập; trên 50% thành viên là điều dưỡng trưởng.	Quyết định và danh sách thành viên, chức danh, tỷ lệ. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
5	Phòng hoặc tổ điều dưỡng đã thành lập đúng đối tượng áp dụng.	Quyết định tổ chức; hồ sơ hạng bệnh viện. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
6	Bổ nhiệm đủ điều dưỡng trưởng khoa; xử lý vị trí thiếu trong thời hạn 6 tháng khi có người nghỉ hoặc chuyển.	Danh sách khoa, quyết định bổ nhiệm, theo dõi vị trí trống. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
7	Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ công tác của phòng hoặc tổ.	Quy định được phê duyệt và hồ sơ phổ biến. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……

2.3 Các tiểu mục mức 3

Mục	Yêu cầu diễn giải	Minh chứng và kết quả
8	Có bản mô tả công việc cho các vị trí điều dưỡng.	Bản mô tả công việc, phân công và xác nhận. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
9	Kế hoạch năm được xây dựng trong quý I hoặc quý IV năm trước và được phê duyệt.	Kế hoạch có ngày lập, ngày phê duyệt. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
10	Phòng hoặc tổ là đầu mối triển khai kế hoạch.	Phân công, báo cáo tiến độ và hồ sơ triển khai. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
11	Xây dựng và phổ biến công cụ kiểm tra, giám sát, đánh giá chăm sóc.	Bảng kiểm, hướng dẫn chấm, hồ sơ phổ biến và sử dụng. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
12	Cập nhật hằng ngày nhân lực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và người bệnh để điều phối.	Dữ liệu hằng ngày và quyết định điều phối thực tế. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
13	Điều dưỡng trưởng có trình độ đại học từ 30% trở lên.	Danh sách mẫu số, văn bằng và phép tính. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
14	Điều dưỡng trưởng có đào tạo quản lý đáp ứng ghi chú của tiêu chí hoặc tương đương hoặc bằng thạc sĩ quản lý bệnh viện từ 30% trở lên.	Chứng chỉ, chương trình, đơn vị đào tạo, văn bằng, phép tính. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
15	Hội đồng rà soát, cập nhật quy định và quy trình chăm sóc; sinh hoạt ít nhất mỗi năm một lần.	Biên bản họp và tài liệu sửa đổi có kiểm soát phiên bản. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……

2.4 Các tiểu mục mức 4

Mục	Yêu cầu diễn giải	Minh chứng và kết quả
16	Cập nhật hằng ngày nhân lực và người bệnh bằng phần mềm, phục vụ điều phối.	Phần mềm, dữ liệu ngày, quyền truy cập và minh chứng sử dụng. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
17	Điều dưỡng trưởng có trình độ đại học từ 50% trở lên.	Danh sách và văn bằng, tỷ lệ. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
18	Điều dưỡng trưởng có đào tạo quản lý đáp ứng điều kiện từ 50% trở lên.	Hồ sơ đào tạo hợp lệ và tỷ lệ. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
19	Hội đồng xây dựng và cập nhật quy trình chăm sóc.	Danh mục, biên bản thẩm định, quy trình được phê duyệt. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
20	Có ít nhất 10 chỉ số; bao gồm 5 nội dung nêu trong tiêu chí.	Danh mục và định nghĩa chỉ số; xem phần 8. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
21	Đo lường, đánh giá định kỳ theo tần suất bệnh viện quy định.	Quy định tần suất và dữ liệu, báo cáo các kỳ. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
22	Theo dõi biến động chỉ số theo thời gian, có biểu đồ và phân tích xu hướng.	Biểu đồ từ dữ liệu thực tế và nhận xét xu hướng. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
23	Đánh giá kế hoạch năm, có báo cáo và hạn chế cần khắc phục.	Báo cáo năm, hạn chế và kiến nghị. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……

2.5 Các tiểu mục mức 5

Mục	Yêu cầu diễn giải	Minh chứng và kết quả
24	Điều dưỡng trưởng có trình độ đại học từ 70% trở lên.	Danh sách chốt kỳ, văn bằng và tỷ lệ. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
25	Điều dưỡng trưởng có đào tạo quản lý đáp ứng điều kiện từ 70% trở lên.	Hồ sơ đào tạo hợp lệ và tỷ lệ. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
26	Dùng kết quả đánh giá kế hoạch để cải tiến chăm sóc và công tác điều dưỡng.	Vấn đề từ báo cáo, biện pháp và kết quả sau thực hiện. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
27	Nghiên cứu, đánh giá chất lượng dựa trên các chỉ số đã xây dựng.	Đề cương, phương pháp, dữ liệu và báo cáo kết quả. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
28	Áp dụng kết quả nghiên cứu để cải tiến.	Thay đổi dựa trên kết quả, triển khai và đánh giá. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
29	Có ít nhất một sáng kiến mới được giám đốc phê duyệt và áp dụng rộng rãi trong bệnh viện.	Văn bản phê duyệt, nội dung sáng kiến và phạm vi áp dụng. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……
30	Đánh giá kết quả sáng kiến đã áp dụng; chỉnh sửa, bổ sung sáng kiến cải tiến.	Báo cáo sau áp dụng, quyết định điều chỉnh và phiên bản mới. Mã hồ sơ: …… Kết quả: ……

Ghi chú đào tạo quản lý: kiểm tra điều kiện lớp đào tạo quản lý điều dưỡng theo chương trình được Bộ Y tế phê duyệt, chức năng đơn vị tổ chức và mã đào tạo liên tục theo ghi chú gốc. Không mặc nhiên tính một giấy chứng nhận tham dự bất kỳ là chứng chỉ quản lý đủ điều kiện.

Danh sách điều dưỡng trưởng dùng làm mẫu số phải thống nhất với đối tượng tiêu chí và được Phòng Điều dưỡng, Tổ chức nhân sự, Quản lý chất lượng xác nhận. Không làm tròn một tỷ lệ dưới ngưỡng thành đạt; nếu mẫu số bằng 0 phải kiểm tra lại hệ thống tổ chức, không gán 100%.

Kết luận tự đánh giá C6.1: ……; tiểu mục còn thiếu: ……; người đánh giá: ……; ngày: ……; người xác nhận: ……

3 Tổ chức quản lý điều dưỡng

Giám đốc ban hành hoặc kiện toàn hệ thống điều dưỡng theo Thông tư 31, xác định trách nhiệm, nhân lực và nguồn lực phù hợp. Hồ sơ cơ cấu Hội đồng phải đối chiếu đồng thời quy định tổ chức hiện hành và yêu cầu tiểu mục 4 C6.1; ghi rõ chức danh của từng thành viên.

Đầu mối	Trách nhiệm và đầu ra
Giám đốc	Phê duyệt quy định, kế hoạch, nguồn lực, nhân sự, sáng kiến; kiểm tra trách nhiệm thực hiện.
Hội đồng điều dưỡng	Tư vấn hoạt động điều dưỡng; thẩm định, rà soát quy định và quy trình; ghi biên bản, kiến nghị và theo dõi thực hiện.
Phòng Điều dưỡng	Lập và triển khai kế hoạch; cập nhật nhân lực, người bệnh hằng ngày; điều phối; giám sát, đào tạo, nghiên cứu và tổng hợp chỉ số.
Điều dưỡng trưởng khoa	Phân công theo năng lực và nhu cầu chăm sóc; đi buồng; kiểm tra hồ sơ và thực hành; xử lý thiếu hụt, báo cáo kết quả.
Điều dưỡng và hộ sinh	Nhận định, lập kế hoạch, chăm sóc, lượng giá, ghi hồ sơ, bàn giao; phát hiện và báo cáo bất thường.
Bác sĩ điều trị	Phối hợp nhận định, phân cấp chăm sóc, chỉ định, xử trí diễn biến và phối hợp kế hoạch chăm sóc.
Quản lý chất lượng và đơn vị liên quan	Thống nhất phương pháp đánh giá, dữ liệu, sự cố và cải tiến; phối hợp kiểm soát nhiễm khuẩn, dược, dinh dưỡng, nhân sự và CNTT.

Phòng Điều dưỡng lập hồ sơ vị trí gồm tên vị trí, mục tiêu, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn năng lực, phối hợp, người thay thế và chỉ số đánh giá. Phân công chăm sóc theo ca và nhóm người bệnh phải nêu người chịu trách nhiệm và đầu mối hỗ trợ; việc điều phối nhân lực được ghi nhận.

Lịch nội bộ đề xuất: khoa báo cáo dữ liệu hằng ngày; Phòng Điều dưỡng tổng hợp giám sát và chỉ số hằng tháng; rà soát liên khoa theo quý; đánh giá kế hoạch hằng năm. Hội đồng sinh hoạt tối thiểu theo tiểu mục 15 và họp thêm khi có vấn đề chuyên môn cần giải quyết. Tần suất cuối cùng do bệnh viện phê duyệt.

4 Quy định chăm sóc người bệnh

Mã đề xuất QD-C6.1-01. Phạm vi: người bệnh nội trú và nhân viên tham gia chăm sóc; các đơn vị khác áp dụng nội dung phù hợp với chức năng. Mục đích: chăm sóc đáp ứng nhu cầu, liên tục, an toàn và có người chịu trách nhiệm.

4.1 Nhận định và lập kế hoạch

Tiếp nhận đúng người bệnh; ưu tiên cấp cứu khi có bất thường. Nhận định tình trạng sức khỏe, khả năng tự chăm sóc, các nhu cầu và nguy cơ; phối hợp bác sĩ phân cấp chăm sóc. Xác định vấn đề ưu tiên, mục tiêu có thể lượng giá, can thiệp, người thực hiện và thời điểm đánh giá lại.

4.2 Tổ chức thực hiện

Bảo đảm chăm sóc nội trú liên tục 24 giờ mỗi ngày bằng phân công ca trực. Thực hiện chăm sóc cơ bản, chuyên khoa, dinh dưỡng, vệ sinh, vận động, hỗ trợ tinh thần và giáo dục sức khỏe theo nhu cầu. Kỹ thuật và sử dụng thuốc thực hiện trong phạm vi chuyên môn, theo chỉ định và quy trình được phê duyệt.

4.3 Theo dõi và báo cáo

Tần suất theo dõi và ngưỡng báo động được xác định theo tình trạng người bệnh, chỉ định, quy trình chuyên khoa và kế hoạch chăm sóc. Không dùng các mốc 1 giờ hoặc 2–4 giờ trong bản gốc làm lịch chung cho mọi người bệnh. Khi có diễn biến bất thường, đánh giá, gọi hỗ trợ và báo bác sĩ kịp thời; ghi thời điểm, can thiệp và đáp ứng.

4.4 Hồ sơ và bàn giao

Ghi nhận trung thực và kịp thời nhận định, kế hoạch, can thiệp, đáp ứng và điều chỉnh. Bàn giao giữa ca, khi chuyển khoa hoặc đơn vị; người nhận xác nhận thông tin và trách nhiệm. Không sao chép diễn biến không được đánh giá thực tế.

4.5 Người bệnh và người hỗ trợ

Giải thích, hướng dẫn phù hợp khả năng tiếp nhận và bảo đảm riêng tư. Người nhà có thể hỗ trợ sinh hoạt theo hướng dẫn; không giao thay việc chuyên môn của nhân viên y tế. Các nhu cầu chưa được đáp ứng phải được báo cáo để bố trí hỗ trợ.

4.6 Kiểm tra thực hiện

Điều dưỡng trưởng khoa kiểm tra phân công, chăm sóc và hồ sơ; Phòng Điều dưỡng giám sát theo kế hoạch được phê duyệt. Ghi sai sót, nguy cơ, biện pháp khắc phục và kiểm tra lại. Kết quả kiểm tra là dữ liệu cải tiến, không chỉ là chữ ký xác nhận.

5 Quy trình tổ chức chăm sóc toàn diện

Mã đề xuất SOP-C6.1-01. Đây là quy trình tổ chức hoạt động chăm sóc, không thay thế quy trình kỹ thuật từng can thiệp. Áp dụng cho người bệnh nội trú; nhân viên được phân công thực hiện và bác sĩ phối hợp.

5.1 Tiếp nhận

Xác minh danh tính theo quy định bệnh viện, kiểm tra hồ sơ và thông tin bàn giao. Đánh giá nhanh dấu hiệu bất thường; cấp cứu được ưu tiên trước thủ tục. Giải thích môi trường, phương tiện gọi hỗ trợ và người phụ trách.

5.2 Nhận định

Đánh giá dấu hiệu sinh tồn theo tình trạng; tri giác, hô hấp, tuần hoàn, đau, vận động, dinh dưỡng, bài tiết, da, vệ sinh, giấc ngủ, tâm lý và nhu cầu giáo dục. Sàng lọc nguy cơ bằng công cụ phù hợp đã được bệnh viện phê duyệt; ghi nhận vấn đề và phối hợp phân cấp chăm sóc.

5.3 Lập kế hoạch

Ưu tiên vấn đề cấp thiết và nguy cơ gây hại. Mỗi vấn đề có mục tiêu, can thiệp, lịch theo dõi, trách nhiệm và thời điểm lượng giá. Kế hoạch phù hợp chỉ định, khả năng nhân lực và tình trạng thực tế; báo cáo khi nguồn lực không đáp ứng.

5.4 Thực hiện

Thực hiện đúng phân công, phạm vi chuyên môn và quy trình; kiểm tra an toàn trước kỹ thuật. Hướng dẫn người bệnh, phối hợp nhóm điều trị và ghi việc đã làm. Khi người bệnh từ chối hoặc không thể thực hiện kế hoạch, ghi lý do, báo bác sĩ và điều chỉnh phù hợp.

5.5 Lượng giá và cập nhật

So sánh đáp ứng với mục tiêu; đánh giá lại khi có diễn biến mới, sau can thiệp hoặc theo lịch. Cập nhật vấn đề, nguy cơ, phân cấp và kế hoạch; trao đổi với bác sĩ khi cần. Không duy trì kế hoạch cũ nếu tình trạng đã thay đổi.

5.6 Bàn giao và hoàn tất

Bàn giao các nguy cơ, bất thường, thuốc và kỹ thuật đang thực hiện, kết quả cần theo dõi và nhiệm vụ chưa hoàn tất. Khi ra viện hoặc chuyển viện, hướng dẫn chăm sóc, dấu hiệu cần quay lại và kế hoạch tiếp tục điều trị theo nhóm điều trị; hoàn thiện hồ sơ.

Đầu ra kiểm tra: có nhận định, phân cấp, kế hoạch, ghi can thiệp và lượng giá; các nhiệm vụ chưa hoàn tất có người nhận; bất thường có dấu vết báo cáo và xử trí.

6 Quy trình bàn giao người bệnh

Mã đề xuất SOP-C6.1-02. Áp dụng giữa ca trực, khi chuyển khoa, chuyển đơn vị hoặc thay người phụ trách. Bàn giao trước khi rời trách nhiệm; ca cấp cứu phối hợp ổn định và chuyển thông tin thiết yếu ngay.

6.1 Chuẩn bị và xác minh

Người giao cập nhật hồ sơ, kiểm tra chỉ định và công việc còn lại; người nhận sẵn sàng tiếp nhận. Xác minh người bệnh bằng các thông tin định danh theo quy định bệnh viện. Số giường hỗ trợ xác định vị trí nhưng không thay định danh. Bàn giao tại giường khi phù hợp, bảo đảm riêng tư và an toàn.

6.2 Nội dung ISBAR

Thành phần	Thông tin cần trao đổi
I — Nhận diện	Người giao, người nhận; người bệnh, mã hồ sơ và thông tin định danh được kiểm tra.
S — Tình huống	Lý do bàn giao, tình trạng hiện tại, bất thường và mức độ ưu tiên.
B — Bối cảnh	Chẩn đoán, tiền sử liên quan, dị ứng, can thiệp gần đây, chỉ định và thông tin cần biết.
A — Nhận định	Diễn biến, dấu hiệu sinh tồn đáng chú ý, phân cấp chăm sóc, nguy cơ và đáp ứng can thiệp.
R — Đề nghị	Việc cần làm, kết quả chờ, lịch theo dõi, ngưỡng báo bác sĩ và người chịu trách nhiệm.

6.3 Xác nhận và ghi nhận

Người nhận hỏi lại điểm chưa rõ và nhắc lại thông tin quan trọng, nhất là nguy cơ, chỉ định và công việc còn lại. Hai bên kiểm tra người bệnh, thuốc hoặc dịch đang dùng, đường truyền và thiết bị có liên quan. Khi phát hiện chênh lệch, làm rõ với người giao hoặc bác sĩ, không suy đoán để thực hiện.

Ghi thời điểm, thông tin thiết yếu và chữ ký hoặc xác nhận điện tử hợp lệ. Nếu chuyển khoa, xác nhận đơn vị nhận, phương tiện, nhân viên đi kèm và điều kiện theo dõi theo tình trạng. Người giao bảo đảm có người tiếp nhận trách nhiệm rõ ràng.

7 Phân cấp chăm sóc và theo dõi nguy cơ

7.1 Ba cấp chăm sóc

Theo Điều 4 Thông tư 31/2021/TT-BYT, phân cấp gồm I, II và III. Loại bỏ cấp IV trong bản nguồn. Nội dung dưới đây diễn giải theo mức phụ thuộc và tình trạng; không thay thế đánh giá người bệnh cụ thể.

Cấp	Đặc điểm	Tổ chức chăm sóc
I	Nặng, nguy kịch; không tự thực hiện sinh hoạt cá nhân hoặc phải bất động theo yêu cầu chuyên môn, phụ thuộc hoàn toàn.	Chăm sóc toàn diện và liên tục; nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi, hỗ trợ toàn bộ nhu cầu.
II	Tình trạng nặng, vận động bị hạn chế một phần do sức khỏe hoặc chuyên môn; phụ thuộc phần nhiều.	Theo dõi và hỗ trợ phần lớn hoạt động cá nhân; đánh giá đáp ứng và diễn biến.
III	Vận động, đi lại không hạn chế; tự thực hiện tất cả hoặc hầu hết sinh hoạt.	Hướng dẫn, theo dõi và hỗ trợ theo nhu cầu, tình trạng và chỉ định.

Điều dưỡng nhận định và phối hợp bác sĩ phân cấp, cập nhật trong hồ sơ và phân công. Đánh giá lại khi tình trạng hoặc mức tự chăm sóc thay đổi. Lịch theo dõi cụ thể được ghi trong kế hoạch và chỉ định; cấp chăm sóc không tự quyết định một khoảng cách giờ cố định cho tất cả người bệnh.

7.2 Quản lý người bệnh nguy cơ cao

Nhóm nguy cơ	Nhận định và biện pháp tổ chức
Té ngã	Đánh giá vận động, tiền sử té ngã, thuốc và yếu tố liên quan bằng công cụ phù hợp. Bố trí hỗ trợ di chuyển, phương tiện gọi trợ giúp, môi trường an toàn; bàn giao và đánh giá lại.
Tổn thương do tỳ đè	Đánh giá da, vận động, dinh dưỡng và nguy cơ bằng công cụ phù hợp. Kế hoạch giảm áp, thay đổi tư thế cá thể hóa, chăm sóc da, phương tiện hỗ trợ và kiểm tra lại.
Dinh dưỡng	Sàng lọc bằng công cụ phù hợp đối tượng. Phối hợp bác sĩ và dinh dưỡng; theo dõi khả năng ăn, dung nạp và nhu cầu hỗ trợ. Không chỉ dùng BMI để kết luận.
Diễn biến nặng	Nhận định bất thường tri giác, hô hấp, tuần hoàn và các dấu hiệu chuyên khoa. Dùng công cụ cảnh báo sớm phù hợp nếu được phê duyệt; tăng theo dõi, báo bác sĩ và gọi cấp cứu theo tình trạng.

Nhóm nguy cơ	Nhận định và biện pháp tổ chức
Nguy cơ liên quan thuốc và kỹ thuật	Ghi dị ứng, thuốc cần giám sát và thiết bị đang dùng; kiểm tra an toàn, thực hiện theo quy trình chuyên môn, theo dõi đáp ứng và bàn giao.

Danh sách nguy cơ phải có kế hoạch và người chịu trách nhiệm; không chỉ gắn nhãn. Công cụ, ngưỡng, lịch đánh giá lại và hướng dẫn can thiệp cụ thể do hội đồng chuyên môn thẩm định. Bảo vệ thông tin cá nhân khi lưu bảng hoặc phần mềm.

8 Chỉ số chất lượng và kế hoạch giám sát

Đề xuất 10 chỉ số dưới đây bao gồm 5 nội dung nêu tại tiểu mục 20. Bệnh viện phê duyệt định nghĩa, kỳ, nguồn, mẫu số, cách thu thập và mục tiêu trước khi đo; giữ ổn định định nghĩa để so sánh. Các công thức là đề xuất vận hành, không phải ngưỡng chấm mức do QĐ 6858 đặt ra.

8.1 Tổn thương do tỳ đè mới trong viện

Công thức và phạm vi: Số người bệnh xuất viện kỳ đo có tổn thương mới trong viện / tổng người bệnh xuất viện kỳ đo ×100%. Ghi nhận khi nhập viện để phân biệt có sẵn; đếm một người một lần.

Nguồn và kỳ đề xuất: Hồ sơ, kiểm tra da; tháng. Đầu mối: Phòng Điều dưỡng phối hợp khoa và đơn vị liên quan. Mục tiêu phê duyệt: ……

8.2 Tuân thủ quy trình kỹ thuật

Công thức và phạm vi: Số lần thực hiện đạt bảng kiểm / tổng lần được quan sát hợp lệ ×100%. Quy định trước các bước bắt buộc, loại kỹ thuật và cách chọn mẫu.

Nguồn và kỳ đề xuất: Bảng kiểm quan sát; tháng. Đầu mối: Phòng Điều dưỡng phối hợp khoa và đơn vị liên quan. Mục tiêu phê duyệt: ……

8.3 Sự cố do dùng thuốc

Công thức và phạm vi: Số sự cố dùng thuốc liên quan người bệnh được phát hiện trong kỳ / tổng ngày điều trị nội trú kỳ đó ×1.000. Tách mức độ, sự cố và suýt xảy ra; không coi ít báo cáo là bằng chứng an toàn.

Nguồn và kỳ đề xuất: Báo cáo và đối chiếu hồ sơ; tháng. Đầu mối: Phòng Điều dưỡng phối hợp khoa và đơn vị liên quan. Mục tiêu phê duyệt: ……

8.4 Điều dưỡng tham gia đào tạo liên tục

Công thức và phạm vi: Số điều dưỡng tham gia hoạt động đào tạo liên tục hợp lệ trong kỳ / tổng điều dưỡng thuộc đối tượng theo danh sách chốt kỳ ×100%. Theo dõi số giờ riêng và không suy ra đủ nghĩa vụ chỉ từ tỷ lệ tham dự.

Nguồn và kỳ đề xuất: Nhân sự và đào tạo; năm, cập nhật quý. Đầu mối: Phòng Điều dưỡng phối hợp khoa và đơn vị liên quan. Mục tiêu phê duyệt: ……

8.5 Điều dưỡng trên giường bệnh

Công thức và phạm vi: Số điều dưỡng quy đổi toàn thời gian thuộc phạm vi / số giường cùng phạm vi. Báo cáo riêng giường kế hoạch và thực kê nếu có; ghi rõ không phải số trực một ca.

Nguồn và kỳ đề xuất: Nhân sự và thống kê giường; tháng. Đầu mối: Phòng Điều dưỡng phối hợp khoa và đơn vị liên quan. Mục tiêu phê duyệt: ……

8.6 Tuân thủ bàn giao

Công thức và phạm vi: Số cuộc bàn giao đạt công cụ / tổng cuộc được quan sát hợp lệ ×100%.

Nguồn và kỳ đề xuất: Quan sát, hồ sơ; tháng. Đầu mối: Phòng Điều dưỡng phối hợp khoa và đơn vị liên quan. Mục tiêu phê duyệt: ……

8.7 Hồ sơ chăm sóc đạt

Công thức và phạm vi: Số hồ sơ đạt bộ tiêu chí đã duyệt / tổng hồ sơ được kiểm tra hợp lệ ×100%.

Nguồn và kỳ đề xuất: Kiểm tra hồ sơ; tháng. Đầu mối: Phòng Điều dưỡng phối hợp khoa và đơn vị liên quan. Mục tiêu phê duyệt: ……

8.8 Té ngã trong viện

Công thức và phạm vi: Số lần té ngã nội trú / tổng ngày điều trị nội trú ×1.000. Tách có và không có tổn thương.

Nguồn và kỳ đề xuất: Sự cố và hồ sơ; tháng. Đầu mối: Phòng Điều dưỡng phối hợp khoa và đơn vị liên quan. Mục tiêu phê duyệt: ……

8.9 Nhận định và kế hoạch nhóm cần hỗ trợ

Công thức và phạm vi: Số người bệnh cấp I hoặc II trong mẫu có nhận định và kế hoạch phù hợp / tổng người bệnh cấp I hoặc II được kiểm tra ×100%. Báo riêng từng cấp.

Nguồn và kỳ đề xuất: Hồ sơ và phân cấp; tháng. Đầu mối: Phòng Điều dưỡng phối hợp khoa và đơn vị liên quan. Mục tiêu phê duyệt: ……

8.10 Hoàn tất khắc phục sau giám sát

Công thức và phạm vi: Số hành động hoàn tất và được xác minh đúng hạn / tổng hành động đến hạn kỳ đo ×100%.

Nguồn và kỳ đề xuất: Sổ khắc phục; tháng. Đầu mối: Phòng Điều dưỡng phối hợp khoa và đơn vị liên quan. Mục tiêu phê duyệt: ……

Mẫu số bằng 0 ghi Không áp dụng hoặc Không tính được và nêu lý do; dữ liệu thiếu không thay bằng 0. Khi một kỳ không có người bệnh nguy cơ hoặc không có mẫu hợp lệ, không gán tỷ lệ 100%. Mục tiêu ≥95% của bản gốc chỉ được sử dụng nếu bệnh viện phê duyệt và có căn cứ; không gán chung cho cả 10 chỉ số.

8.11 Chu trình giám sát

Phòng Điều dưỡng lập kế hoạch chọn khoa, đối tượng và cỡ mẫu phù hợp; ghi rõ có kiểm tra hồ sơ, quan sát hay phỏng vấn. Đề xuất giám sát hằng tháng, tổng hợp quý và đánh giá năm. C6.1 không đặt yêu cầu chung “audit định kỳ ≥12 tháng” như bản nguồn; tần suất đo theo tiểu mục 21 do bệnh viện quy định.

Các khoa nộp dữ liệu kèm nguồn gốc; Phòng Điều dưỡng và Quản lý chất lượng kiểm tra trùng, thiếu, định nghĩa và mẫu số. Lập biểu đồ theo thời gian, phân tích thay đổi cùng phạm vi và bối cảnh; không đưa số liệu giả vào biểu đồ mẫu. Ưu tiên vấn đề có nguy cơ, giao hành động và kiểm tra lại sau can thiệp.

9 Đào tạo nghiên cứu và cải tiến

9.1 Đào tạo và hồ sơ năng lực

Xây dựng kế hoạch theo khoảng thiếu năng lực, vị trí và nhu cầu chăm sóc. Ưu tiên nhân viên mới, bàn giao, nhận định và kế hoạch, nguy cơ, kỹ thuật, an toàn và giao tiếp. Hồ sơ gồm kế hoạch, chương trình, tài liệu, người hướng dẫn, danh sách, đánh giá trước và sau phù hợp, thực hành được giám sát và báo cáo kết quả. Không ghi hoàn thành khi chỉ có danh sách dự kiến.

Lập danh sách riêng điều dưỡng trưởng, trình độ, chứng chỉ quản lý và thông tin kiểm tra điều kiện tiêu chí. Mỗi người được tính một lần trong từng tỷ lệ; chứng chỉ chưa xác minh điều kiện được ghi Chờ xác minh. Theo dõi tỷ lệ 30%, 50%, 70% tương ứng các mức, không thay bằng tỷ lệ nhân viên toàn bệnh viện.

9.2 Nghiên cứu và đánh giá chất lượng

Từ chỉ số và hạn chế, lựa chọn vấn đề, xác định câu hỏi, phương pháp, đối tượng, cách lấy mẫu, nguồn và kế hoạch phân tích. Thực hiện thẩm định, cho phép và yêu cầu đạo đức, bảo mật phù hợp trước thu thập. Báo cáo kết quả thực tế, hạn chế và đề xuất; ghi rõ nghiên cứu hay đánh giá cải tiến theo phạm vi, không dùng một bảng tổng hợp tháng thay cho toàn bộ hồ sơ nghiên cứu.

9.3 Sáng kiến và đánh giá sau áp dụng

Hồ sơ sáng kiến nêu vấn đề, nội dung mới trong bối cảnh bệnh viện, nguồn lực, kế hoạch và chỉ số đánh giá. Có phê duyệt của giám đốc, chứng cứ áp dụng rộng rãi và báo cáo sau áp dụng. So sánh trước và sau bằng định nghĩa nhất quán; đánh giá cả lợi ích, sai sót mới và khả năng duy trì, sau đó điều chỉnh có phiên bản.

9.4 Lộ trình nội bộ đề xuất

Giai đoạn	Công việc và đầu ra
30 ngày đầu	Rà soát 30 tiểu mục, tổ chức, nhân sự và nguồn minh chứng; xác minh thiếu hụt; trình quy định và định nghĩa chỉ số.
Ngày 31–60	Đào tạo, triển khai biểu mẫu, vận hành cập nhật nhân lực bằng phần mềm và đo chỉ số theo kế hoạch.
Ngày 61–90	Kiểm tra thực hành, phân tích dữ liệu ban đầu, triển khai biện pháp ưu tiên và kiểm tra lại.
Sau 90 ngày và theo chu kỳ	Duy trì dữ liệu, nghiên cứu hoặc đánh giá theo kế hoạch; áp dụng sáng kiến, đánh giá và báo cáo năm.

Lộ trình không bảo đảm đạt mức 5 trong 90 ngày. Các bằng chứng theo năm, nghiên cứu và kết quả sau cải tiến cần thời gian thực hiện thực tế. Ngày bắt đầu, nguồn lực và người chịu trách nhiệm do bệnh viện phê duyệt.

10 Biểu mẫu sử dụng

Các biểu mẫu là đề xuất nội bộ, có thể tích hợp với hồ sơ bệnh án và phần mềm đã được phê duyệt để tránh ghi trùng. Phiếu lâm sàng phải được thẩm định về nội dung, quyền truy cập và cách lưu trước sử dụng. Không thay thế mẫu hồ sơ bệnh án bắt buộc.

10.1 Danh mục và kiểm soát minh chứng

Mã đề xuất BM-C6.1-01

Kỳ: ……; người quản lý: ……

Mục C6.1	Minh chứng và phiên bản	Nơi lưu và người phụ trách	Kết quả và thiếu hụt
1	……	……	……
2	……	……	……
3	……	……	……
4	……	……	……
5	……	……	……
6	……	……	……
7	……	……	……
8	……	……	……
9	……	……	……
10	……	……	……
11	……	……	……
12	……	……	……
13	……	……	……
14	……	……	……
15	……	……	……
16	……	……	……
17	……	……	……
18	……	……	……
19	……	……	……
20	……	……	……

Mục C6.1	Minh chứng và phiên bản	Nơi lưu và người phụ trách	Kết quả và thiếu hụt
21	……	……	……
22	……	……	……
23	……	……	……
24	……	……	……
25	……	……	……
26	……	……	……
27	……	……	……
28	……	……	……
29	……	……	……
30	……	……	……

10.2 Danh sách điều dưỡng trưởng và năng lực

Mã đề xuất BM-C6.1-02

Chốt ngày: ……; phạm vi khoa: ……

Họ tên và khoa	Bổ nhiệm và trình độ	Quản lý và điều kiện kiểm tra	Kết quả xác minh
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……

Tổng điều dưỡng trưởng N: ……; có trình độ đại học A: ……; đáp ứng đào tạo quản lý B: ……; A/N ×100%: ……; B/N ×100%: ……; đơn vị và người xác nhận: ……

10.3 Theo dõi nhân lực và người bệnh hằng ngày

Mã đề xuất BM-C6.1-03

Ngày và giờ chốt: ……; nguồn phần mềm: ……

Khoa	NB và cấp I II III	ĐD HS KTV thực có theo ca	Thiếu hụt và điều phối
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……

Ghi số người thực có và vai trò; tránh đếm một người vào nhiều ca cùng thời điểm. Lưu vết điều phối, thời điểm và người quyết định. Tổng hợp toàn viện: ……; người cập nhật: ……; người kiểm tra: ……

10.4 Nhận định và kế hoạch chăm sóc

Mã đề xuất BM-C6.1-04

Họ tên và mã NB: ……; khoa: ……; ngày giờ: ……; dị ứng: ……; phân cấp: ……

Vấn đề và nhận định	Mục tiêu và thời điểm	Can thiệp và theo dõi	Đáp ứng và điều chỉnh
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……

Điều dưỡng lập và thực hiện: ……; phối hợp bác sĩ: ……; người nhận bàn giao: ……; ngày giờ đánh giá lại: ……

10.5 Phiếu bàn giao ISBAR

Mã đề xuất BM-C6.1-05

Ngày giờ: ……; giao: ……; nhận: ……; hình thức bàn giao: ……

Thành phần	Thông tin bàn giao
I Nhận diện và xác minh	……
S Tình trạng hiện tại	……
B Bối cảnh và dị ứng	……
A Nhận định và nguy cơ	……
R Việc cần làm và thời hạn	……

Thông tin quan trọng được nhắc lại: ……; điểm chênh lệch và cách làm rõ: ……; người giao xác nhận: ……; người nhận xác nhận: ……

10.6 Phiếu phân cấp và đánh giá lại

Mã đề xuất BM-C6.1-06

Họ tên và mã NB: ……; khoa: ……

Ngày giờ	Tình trạng và mức phụ thuộc	Cấp chăm sóc và kế hoạch	ĐD và BS phối hợp
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……

10.7 Theo dõi người bệnh nguy cơ cao

Mã đề xuất BM-C6.1-07

Khoa: ……; ngày: ……; lưu trong hệ thống được phân quyền

Mã NB và nguy cơ	Công cụ và kết quả	Biện pháp và lịch đánh giá lại	Phụ trách và đáp ứng
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……

Té ngã và tỳ đè: ghi công cụ, ngày giờ, mức nguy cơ, biện pháp thực hiện và kết quả đánh giá lại. Dùng thang điểm phù hợp nhóm người bệnh được bệnh viện phê duyệt; không tự đặt điểm cắt trong phiếu này.

10.8 Bảng kiểm giám sát chăm sóc

Mã đề xuất BM-C6.1-08

Khoa: ……; ngày: ……; mã mẫu: ……; phương pháp chọn mẫu: ……

STT	Nội dung kiểm tra	Đạt Chưa đạt KAD	Bằng chứng và khắc phục
1	Xác minh đúng người bệnh	……	……
2	Nhận định nhu cầu và nguy cơ	……	……
3	Phân cấp phù hợp và có cập nhật	……	……
4	Kế hoạch với mục tiêu và can thiệp	……	……
5	Thực hiện chăm sóc theo phân công	……	……
6	Theo dõi và báo bất thường	……	……
7	Ghi can thiệp và lượng giá	……	……
8	Bàn giao nguy cơ và việc còn lại	……	……
9	Hướng dẫn phù hợp người bệnh	……	……
10	Phương tiện và nguồn lực đáp ứng	……	……

KAD là không áp dụng, phải có lý do. Quy định trước cách xác định hồ sơ hoặc lần chăm sóc đạt tổng thể; các bước an toàn bắt buộc không được bù bằng điểm khác. Người kiểm tra: ……; đại diện khoa: ……; hạn kiểm tra lại: ……

10.9 Báo cáo chỉ số chất lượng

Mã đề xuất BM-C6.1-09

Khoa và kỳ: ……; định nghĩa phiên bản: ……

Mã chỉ số	Tử số và mẫu số	Kết quả và mục tiêu	Nhận xét và hành động
01	……	……	……
02	……	……	……
03	……	……	……
04	……	……	……
05	……	……	……
06	……	……	……
07	……	……	……
08	……	……	……
09	……	……	……
10	……	……	……

Nguồn dữ liệu và cỡ mẫu: ……; dữ liệu thiếu: ……; biểu đồ theo thời gian đính kèm: ……; người lập và người kiểm tra: ……

10.10 Theo dõi khắc phục và cải tiến

Mã đề xuất BM-C6.1-10

Đơn vị: ……; kỳ: ……

Vấn đề và nguồn	Hành động và phụ trách	Hạn và kết quả	Xác minh và duy trì
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……

10.11 Theo dõi đào tạo và đánh giá năng lực

Mã đề xuất BM-C6.1-11

Chương trình và ngày: ……; giảng viên: ……

Họ tên và vị trí	Nội dung và thời lượng	Đánh giá kiến thức thực hành	Kết quả và kế hoạch bổ sung
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……

Điều kiện công nhận hoàn thành: ……; căn cứ hồ sơ: ……; người xác nhận: ……; theo dõi thực hành sau đào tạo: ……

10.12 Biên bản họp Hội đồng điều dưỡng

Mã đề xuất BM-C6.1-12

Ngày giờ và địa điểm: ……; chủ trì: ……; thư ký: ……; thành viên tham dự và vắng: ……

Nội dung	Kết quả ghi nhận
Rà soát tổ chức và kế hoạch	……
Quy định quy trình cần cập nhật	……
Kết quả chỉ số và vấn đề	……
Quyết nghị và phân công	……
Thời hạn và cách kiểm tra lại	……

Tài liệu kèm theo và phiên bản: ……; chủ trì ký: ……; thư ký ký: ……; xác nhận thành viên theo quy định: ……

10.13 Báo cáo đánh giá nghiên cứu hoặc sáng kiến

Mã đề xuất BM-C6.1-13

Tên đề tài hoặc sáng kiến: ……; chủ trì: ……; văn bản cho phép phê duyệt: ……

Phần báo cáo	Nội dung cần điền
Vấn đề và chỉ số làm căn cứ	……
Mục tiêu và phương pháp	……
Đối tượng nguồn dữ liệu bảo mật	……
Kết quả thực tế và hạn chế	……
Giải pháp đã áp dụng và phạm vi	……
Đánh giá sau áp dụng	……
Điều chỉnh và duy trì	……

Minh chứng trước và sau: ……; xác nhận phạm vi áp dụng: ……; người thẩm định: ……; kết luận phê duyệt: ……

11 Rà soát trước ban hành và nguồn đối chiếu

Trước ban hành, hoàn tất cơ cấu và nhân sự thật, mã văn bản, thẩm định chuyên môn, mục tiêu và tần suất chỉ số, công cụ nguy cơ, kế hoạch theo dõi, nguồn lực và cách lưu hồ sơ. Ban giám đốc phê duyệt theo thẩm quyền; phổ biến, đào tạo và kiểm tra thực hiện. Không điền hồi tố hồ sơ minh chứng để hợp thức hóa hoạt động chưa thực hiện.

Những thay đổi so với C6.1.docx: bỏ kết luận mặc định đạt mức 5; bổ sung đối chiếu 30 tiểu mục và chứng cứ; sửa 4 cấp thành 3 cấp; bỏ mốc giờ theo dõi áp dụng chung; phân biệt đề xuất 95% và yêu cầu tiêu chí; bổ sung 10 chỉ số, định nghĩa, trách nhiệm và 13 biểu mẫu; bỏ ký hiệu quảng bá, “ăn điểm”, “Top of Form” và “Bottom of Form”.

Các nguồn đã đối chiếu ngày 13/10/2026:

Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016, Bộ tiêu chí phiên bản 2.0; C6.1 trang in 91–92. Bản Bộ Y tế do Sở Y tế Lai Châu đăng tải.

https://soyte.laichau.gov.vn/upload/2000987/20221006/quyet-djinh-6858qdj-byt-nam-2016-ve-bo-tieu-chi-chAt-luong-benh-vien-viet-nam-do-bo-truong-bo-y-te-ban-hanh_5faed01464.pdf

Thông tư 31/2021/TT-BYT; Điều 4 và các nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức hoạt động điều dưỡng. CSDL quốc gia ghi còn hiệu lực tại thời điểm tra cứu.

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956

Lịch sử hiệu lực Thông tư 31/2021/TT-BYT.

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-lichsu.aspx?ItemID=152956

Hướng dẫn kiểm tra đánh giá kỳ 2024–2025 do Bộ Y tế đăng tải: có sử dụng Bộ tiêu chí phiên bản 2.0. Đây là nguồn tham khảo kỳ trước, không mặc nhiên là hướng dẫn kỳ 2026.

https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/attach/getfile/411692

Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023: đề cương và thể thức quy trình kỹ thuật; bản PDF người dùng cung cấp.

3023_QD-BYT_574343.pdf

File nguồn để hoàn thiện.

C6.1.docx

Nguồn nội bộ chưa được cung cấp: quyết định tổ chức và nhân sự, hồ sơ trình độ, kế hoạch và báo cáo năm, dữ liệu phần mềm, chỉ số, nghiên cứu, sáng kiến và minh chứng triển khai. Bệnh viện bổ sung trước khi kết luận mức đạt.